

보건복지부 고시 제2023-82호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2023-58호(2023. 3. 31.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2023년 4월 28일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[399] Burosumab 주사제(품명: 크리스비타주사액)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 당뇨병용제, [117] Paliperidone palmitate 주사제 (품명: 인베가서스티나주사, 인베가트린자주사), [142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램), [142] Secukinumab 주사제(품명: 코센틱스주사 등), [149] Leukotriene 조절제 Montelukast 경구제(품명: 싱골레이정 등, 싱골레이츄정 등, 싱골레이세립 등, 싱골로드속봉정 등), Montelukast 및 levocetirizine 복합제(품명: 몬테리진캡슐, 몬테리진츄정), Pranlukast 경구제(품명: 프라카논정, 오논캡셀 등, 씨투스현탁정 등, 오논드라이시럽 등), Zafirlukast 경구제(품명: 아콜레이트정 20밀리그램), Petasites hybridus CO2 Extracts 경구제(품명: 코살린정), [339] Emicizumab 주사제(품명: 헴리브라피하주사 30mg 등)"의 구분, 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2023년 5월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[399] 따로 분류되지 않는 대사성 의약품			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[399] Burosumab 주사제 (품명: 크리스비타주사 액)	<신 설>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정 하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 및 시작기준 기존 치료제(활성형 vitamin D 제제 등)를 6개월 이상 지속 투여하였 음에도 적절하게 조절되지 않는 만 1세~만 12세 X염색체 연관 저인 산혈증성(XLH) 구루병 환자(단, 만 12세 초과 만 18세 미만인 경우 방사선학적 검사로 골성장 진행이 확인되어 약제 반응이 있을 것으로 판단되는 경우 포함)로 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 임상 증상(하나 이상 만족) - 성장지연, 치아이상, 하지골변형, 두개골 조기융합, 두개골 내 압력 상승 등 2) 방사선학적 검사 - RSS(rickets severity score) 2점 이상 3) 생화학적 검사(모두 만족) - 저인산혈증(3.0mg/dL 미만) - 신장 인 소실 확인(TmP/GFR 참고치 미만)	○‘크리스비타주사액10 밀리그램, 20밀리그램, 30밀리그램’이 신규 등재 예정임에 따라, 급여기준을 신설함

		- 정상 혈청 크레아티닌 4) 유전자 검사 - PHEX gene mutation 확인 나. 제외대상 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여시작 대상에서 제외함 - 다 음 - 1) Tanner stage $\geq$ 4점 2) 신장(Height) > 연령 및 성별에 대한 50번째 백분위수 3) 12개월 이내 성장 호르몬 치료를 받은 경우 4) 부갑상선호르몬(Parathyroid hormone) > 19 pmol/L(180 pg/mL) 5) 저칼슘혈증, 고칼슘혈증 6) Grade 4 이상의 신석회증(nephrocalcinosis) 다. 평가방법 매 12개월마다 반응평가(RSS, 방사선학적 검사, 생화학적 검사)를 실시하여야 함 라. 중지기준 1) 치료 시작 후 매 12개월 간격의 반응평가 결과가 다음 중 어느 하나라도 해당하는 경우 - 다 음 - 가) RSS(rickets severity score) (1) 1차 반응평가(치료시작 후 12개월)에서 RSS 점수가 치료시작 시점보다 개선되지 않은 경우 또는 (2) 이후 반응평가에서 1차 반응평가 시의 개선된 RSS 점수가 유	
--	--	---	--

		지되지 않은 경우 나) 생화학적 검사 결과가 치료시작 기저치 대비 개선되지 않은 경우 (하나 이상 해당) (1) 혈청 인 수치 감소 (2) TmP/GFR 감소 다) 부갑상선기능항진증(hyperparathyroidism) 라) 신석회증(nephrocalcinosis) 마) 방사선학적 평가로 새로 발생한 골절 또는 가골절 확인 2) 지속투여 중 만 18세가 된 성인 환자 3) 기타 위원회에서 투여 중지가 필요하다고 판단되는 경우 마. 동 약제의 요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청하여 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여하는 경우 는 추후 승인 시 종전 투여분을 소급 인정함. 2. 투여 및 약제 관리 가. 원내투여를 원칙으로 함. 다만, 의사는 자가투여 적용의 타당성(즉 각적인 용량 변경이 필요 없는 경우 등)을 판단하여 안정된 질병활 동도를 보이고 부작용이 없는 환자에서 투여방법에 대해 적절하게 교육 받았을 경우에만 자가 투여를 인정하며, 장기처방 시 1회 처 방기간은 최대 4주 분까지로 함. 나. 약제 투여기간 및 관리 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자 가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함.	
--	--	--	--

		3. 크리스비타주의 사전승인을 위한 방법·절차 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.	
※ 관련근거 1) Current Medical Diagnosis & Treatment, 62판(2023) 2) Marcus and Feldman's Osteoporosis(2021) 3) Clinical practice recommendations for the diagnosis and management of X-linked hypophosphataemia. Nat Rev Nephrol (2019)15(7):435-55. 4) Erik A. Imel et al. Burosumab versus continuation of conventional therapy in children with X-linked hypophosphatemia: a randomised, ·active-controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet 2019 Jun; 393(10189): 2416-2417 5) Karl L Insogna et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial Evaluating the Efficacy of Burosumab, an Anti-FGF23 ·Antibody, in Adults With X-Linked Hypophosphatemia: Week 24 Primary Analysis. J Bone miner Res 2018 Aug; 33(8): 1383-1393 6) Anthony A. Portale et al. Continued Beneficial Effects of Burosumab in Adults with X-Linked Hypophosphatemia: Results from a 24-Week ·Treatment Continuation Period After a 24-Week Double-Blind Placebo-Controlled Period. Calcifi Tissue int 2019 Mar; 105: 271-284 7) Yasuo Imanishi et al. Interim Analysis of a Phase 2 Open-Label Trial Assessing Burosumab Efficacy and Safety in Patients With Tumor-Induced ·Osteomalacia. J Bone miner Res 2020 Sep; 10.1002 8) 대한내분비학회(대내학 제 2020-195호, 2020.11.30.) 9) 대한의학유전학회(의유학 제 2020-83호, 2020.11.27.) 10) 대한유전성대사질환학회(유대학 제2020-24호, 2020.11.27.) 11) 대한암학회(대암학 제2020-120호, 2020.11.24.) 12) NICE(2018.10.10.) Burosumab for treating X-linked hypophosphataemia in children and young people 13) SMC(2020.1.10.) Burosumab 10mg, 20mg, and 30mg solution for injection (Crysvita®) 14) CADTH(2020.5.27.) BUROSUMAB, Indication: Treatment of X-linked hypophosphatemia.			

[별지 2]

[일반원칙] 당뇨병용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 당뇨병용제	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형 당뇨병) 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담함. - 아 래 - 가. 경구용 당뇨병치료제 1) 단독요법 (현행과 같음) 2) 병용요법 가) 2제요법 (1) ~ (2) (생 략) (3) 인정 가능 2제 요법	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형 당뇨병) 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담함. - 아 래 - 가. 경구용 당뇨병치료제 1) 단독요법 (현행과 같음) 2) 병용요법 가) 2제요법 (1) ~ (2) (생 략) (3) 인정 가능 2제 요법	○ Enavogliflozin 경구제(품명: 엔블로정 등) 단일제 및 Dapagliflozin + Glimepiride 복합 경구제(품명: 다파그린지정 10/4 밀리그램 등 4품목), Dapagliflozin + Gemigliptin 복합경구제(품명: 제미다파정), Dapagliflozin + Sitagliptin 복합 경구제

[일반원칙] 당뇨병용제

[illegible]

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	inhibitor (2) metformin + SGLT-2 inhibitor(ertugliflozin 제외) + Thiazolidinedione 나. Insulin 요법 1) 단독요법 (생 략) 2) 경구제와 병용요법 Insulin 단독요법 또는 경구용 당뇨병치료제 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 Insulin과 경구용 당뇨병치료제의 병용요법을 인정함. 가) Insulin과 경구용 당뇨병치료제 2종까지 병용요법을 인정함. 단, 경구용 당뇨병 치료제 2제 요법에서 인정되지 않는 약제의 조합이 포함되어서는 아니 됨. ※ 대상약제 [경구제 중 단일제]	inhibitor (2) metformin + SGLT-2 inhibitor(ertugliflozin, <u>enavogliflozin</u> 제외) + Thiazolidinedione 나. Insulin 요법 1) 단독요법 (현행과 같음) 2) 경구제와 병용요법 Insulin 단독요법 또는 경구용 당뇨병치료제 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 Insulin과 경구용 당뇨병치료제의 병용요법을 인정함. 가) Insulin과 경구용 당뇨병치료제 2종까지 병용요법을 인정함. 단, 경구용 당뇨병 치료제 2제 요법에서 인정되지 않는 약제의 조합이 포함되어서는 아니 됨. <u>나) Enavogliflozin은 Insulin 주사제와 병용 시 인정하지 아니함.</u> ※ 대상약제 [경구제 중 단일제]	5/100밀리그램)이 등재됨에 따라, 「당뇨병용제 일반원칙」에 따라 급여인정하고 대상 약제에 각 약제의 성분 조합을 추가함. ○ SGLT-2 inhibitor + DPP-IV inhibitor 복합제는 Metformin HCl 병용시에만 요양

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	· Biguanide계: Metformin HCl · Sulfonylurea계: Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide · Meglitinide계: Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide · α-glucosidase inhibitor계: Acarbose, Miglitol, Voglibose · Thiazolidinedione계: Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl · DPP-IV inhibitor계: Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin phosphate, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate,, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate · SGLT-2 inhibitor계: Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin [경구제 중 복합제]	· Biguanide계: Metformin HCl · Sulfonylurea계: Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide · Meglitinide계: Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide · α-glucosidase inhibitor계: Acarbose, Miglitol, Voglibose · Thiazolidinedione계: Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl · DPP-IV inhibitor계: Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin phosphate, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate,, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate · SGLT-2 inhibitor계: Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, <u>Enavogliflozin</u> [경구제 중 복합제]	급여 인정 함을 명시 함

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	· Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide +Metformin HCl, Glimepiride+ Metformin HCl · Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide +Metformin HCl · Voglibose+Metformin HCl · Lobeglitazone sulfate+Metformin HCl, Pioglitazone HCl+Metformin HCl · Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride · Alogliptin+Metformin HCl, Anagliptin +Metformin HCl, Evogliptin+ Metformin HCl, Gemigliptin+Metformin HCl, Linagliptin+Metformin HCl, Saxagliptin +Metformin HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Teneigliptin HBr +Metformin HCl, Teneigliptin HCl +Metformin HCl, Teneigliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metformin HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin	· Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide +Metformin HCl, Glimepiride+ Metformin HCl · Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide +Metformin HCl · Voglibose+Metformin HCl · Lobeglitazone sulfate+Metformin HCl, Pioglitazone HCl+Metformin HCl · Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride · Alogliptin+Metformin HCl, Anagliptin +Metformin HCl, Evogliptin+ Metformin HCl, Gemigliptin+Metformin HCl, Linagliptin+Metformin HCl, Saxagliptin +Metformin HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Teneigliptin HBr +Metformin HCl, Teneigliptin HCl +Metformin HCl, Teneigliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metformin HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin	

[일반원칙] 당뇨병용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	nitrate+Metformin HCl · Alogliptin+Pioglitazone HCl · Dapagliflozin+Metformin HCl, Empagliflozin + Metformin HCl [주사제] (생 략)	nitrate+Metformin HCl · Alogliptin+Pioglitazone HCl · Dapagliflozin+Metformin HCl, <u>Dapagliflozin+Glimepiride</u> , Empagliflozin + Metformin HCl · <u>Dapagliflozin+Gemigliptin,</u> <u>Dapagliflozin+Sitagliptin,</u> <u>Dapagliflozin +Saxagliptin,</u> <u>Empagliflozin+Linagliptin,</u> <u>Ertugliflozin+Sitagliptin</u> (단, SGLT-2 inhibitor + DPP-IV inhibitor <u>복합제는 Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)</u> [주사제] (현행과 같음)	

※ 관련근거

<요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>

[117] 정신신경용제				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[117] Paliperidone palmitate 주사제 (품명: 인베가서스티나주사, 인베가트린자주사)	<추 가>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요 양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부 담토록 함. - 아 래 - ○ 조현병의 치료	[117] Paliperidone palmitate 주사제 (품명: 인베가서스티나주사, 인베가트린자주사, <u>인베가하피에라주사</u>)	<u>각 약제별</u> 허가사항 범위 내에 서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인 정기준 이외에는 약값 전액을 환 자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 조현병의 치료	○ ‘인베가하피에라주사 1.092g/3.5mL 등 2품 목’이 신규 등재 예 정임에 따라, 기존 Paliperidone palmitate 주사제 급여기준에 해당 제품명을 추가 하고, 약제별 허가 사항이 다른 점을 고려하여 각 약제별 허가사항 범위 내에서 투여토록 문구를 변경함
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램)	<추 가> 1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (이하 생략)	[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - (현행과 같음)	○ ‘듀피젠트프리필드펜 300밀리그램’이 신규 등재 예정임에 따라, 기존 Dupilumab 주사제 급여기준에 ‘등’ 추가하고, 약제별 허가사항이 다른 점을 고려하여 각 약제별 허가사항 범위 내에서 투여토록 문구를 변경함
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>				

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[142]	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은	○ ‘코센틱스우노레디펜

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
Secukinumab 주사제(품명: 코센티스주사 등)	기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (생 략)	기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (현행과 같음)	300mg/2mL₂이 신 규 등재 예정임에 따라, 기존 Secukinumab 주사제 급여기준을 적용하되, 동 약제가 자가주사제제인 점을 고려하여 자가 주사 및 장기처방에 대한 기준에 해당 제품명을 명시 함
	2. <u>‘코센티스프리필드시린지’와 ‘코센티스센소레디펜’</u> <추 가>이 자가 주사제제인 점을 고려하여, 동 약제의 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함.	2. <u>‘코센티스프리필드시린지’, ‘코센티스센소레디펜’, ‘코센티스우노레디펜’</u>이 자가 주사제제인 점을 고려하여, 동 약제의 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고 이를 요양기관이 관리하여야 함.	
	3. <u>‘코센티스프리필드시린지’와 ‘코센티스센소레디펜’</u> <추 가>의 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 4주분까지로 하며, 원내처방 함을 원칙으로 함. 다만, 최초 투약일로부터	3. <u>‘코센티스프리필드시린지’, ‘코센티스센소레디펜’, ‘코센티스우노레디펜’</u>의 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 4주분까지로 하며, 원내처방 함을 원칙으로 함. 다만, 최초	

[142] 자격요법제(비특이성 면역원제 포함)

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 8~12주분까지 인정함.	투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 최대 8~12주분까지 인정함.	
	4. (생 략)	4. (현행과 같음)	
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 변경 사항>			

[149] 기타의 알레르기용약

현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
[149] Leukotriene 조절제	각 약제의 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준	[149] Leukotriene 조절제	각 약제의 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준	○ Zafirlukast 경구제 (품명: 이콜레이트정20밀리그램)가 「약제

[149] 기타의 알레르기용약

현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
Montelukast 경구제(품명: 싱글레어정 등, 싱글레어츄정 등, 싱글레어세립 등, 싱글로드속봉정 등), Montelukast 및 levocetirizine 복합제(품명: 몬테리진캡슐, 몬테리진츄정) Pramlukast 경구제(품명: 프라카논정, 오논캡셀 등, 씨투스현탁정 등, 오논드라이시럽 등), <u>Zafirlukast 경구제(품명: 아콜레이트정 20밀리그램),</u>	이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 가. Montelukast 경구제, Pramlukast 경구제, <u>Zafirlukast 경구제</u> ○ (생 략) 나. <u>Montelukast 경구제, Pramlukast 경구제</u> ○ (생 략) 1) ~ 3) (생 략) 다. Petasites hybridus CO2 Extracts 경구제 ○ (생 략) 라. Montelukast 및 levocetirizine 복합제 ○ (생 략)	Montelukast 경구제(품명: 싱글레어정 등, 싱글레어츄정 등, 싱글레어세립 등, 싱글로드속봉정 등), Montelukast 및 levocetirizine 복합제(품명: 몬테리진캡슐, 몬테리진츄정) Pramlukast 경구제(품명: 프라카논정, 오논캡셀 등, 씨투스현탁정 등, 오논드라이시럽 등), <u><삭 제></u> Petasites hybridus CO2 Extracts	이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 가. Montelukast 경구제, Pramlukast 경구제 <u><삭 제></u> 1) (현행과 같음) 나. <u><삭 제></u> 2) (현행과 같음) 가) ~ 다) (현행과 같음) 나. Petasites hybridus CO2 Extracts 경구제 ○ (현행과 같음) 다. Montelukast 및 levocetirizine 복합제 ○ (현행과 같음)	급여목록 및 급여상한금액표」고시에서 삭제됨에 따라 고시문구를 현행화함.

[149] 기타의 알레르기용약				
현 행		개 정(안)		사유
구 분	세부인정기준 및 방법	구 분	세부인정기준 및 방법	
Petasites hybridus CO2 Extracts 경구제(품명: 코살린정)		경구제(품명: 코살린정)		
※ 관련근거 . 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」				

[339] 기타의 혈액 및 체액용약			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[339] Emicizumab 주사제 (품명: 헴리브라	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 <u>제8인자 항체를 보유한 중증 A형 혈우병</u>	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. <u>제8인자 항체를 보유한 중증(응고인자 활성도가 1% 미만) A형 혈우병 환자</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견 등을 참조하여, 만 1세 이상의 제8인자 항체를 보유하지

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
피하주사 30mg 등)	<u>환자(응고인자 활성도가 1% 미만)에서 항체 역가가 5BU(Bethesda unit)/mL 이상의 이력이 있으면서 다음의 경우</u> - 다 음 - 1) 만12세 이상: 가) 최근 24주간 출혈건수가 6회 이상으로 우회인자제제를 투여한 경우 또는 나) 면역관용요법에 실패한 경우 2) 만1세이상 만12세미만: 가) 최근 24주간 출혈건수가 3회 이상으로 우회인자제제를 투여한 경우 또는 나) 면역관용요법에 실패한 경우 나. 투여 시 고려사항 ○ 의료진은 상기 가. 투여대상의 경우, 임	<u>가. 투여대상</u> <u>항체역가가 5BU(Bethesda unit)/mL 이상의 이력이 있으면서 다음의 경우</u> - 다 음 - 1) 만12세 이상: 가) 최근 24주간 출혈건수가 6회 이상으로 우회인자제제를 투여한 경우 또는 나) 면역관용요법에 실패한 경우 2) 만1세이상 만12세미만: 가) 최근 24주간 출혈건수가 3회 이상으로 우회인자제제를 투여한 경우 또는 나) 면역관용요법에 실패한 경우 나. 투여 시 고려사항 ○ 의료진은 상기 1. 투여대상의 경우, 임	낮은 중증 A형 혈우병 환자에게 급여를 인정함.

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	상적 유용성이 허가사항의 사용상의 주의사항(경고, 이상반응, 일반적주의 항목 등)에 따른 위험성보다 높다고 판단되는 경우, 면역관용요법을 포함한 치료법과 동 약제 투여와의 연관성 등에 대하여 해당 환자에게 충분히 설명한 이후, 동 약제 투여에 대하여 해당 환자(보호자)가 동의한 경우에 투여하도록 함(진료기록부에 설명·동의서 별도 작성·보관). <u>다. 투여방법(→ 3호로 변경)</u> 부하용량 투여 기간 동안 원내 투여를 원칙으로 하며, 해당기간 동안 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이상 성공적인 자가투여를 병원에서 확인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 4주분까지 요양급여를 인정함. 이후 처방은 투약 등의 확인을 위한 일지를 환자 및 보호자가 작성하고 이를	상적 유용성이 허가사항의 사용상의 주의사항(경고, 이상반응, 일반적주의 항목 등)에 따른 위험성보다 높다고 판단되는 경우, 면역관용요법을 포함한 치료법과 동 약제 투여와의 연관성 등에 대하여 해당 환자에게 충분히 설명한 이후, 동 약제 투여에 대하여 해당 환자(보호자)가 동의한 경우에 투여하도록 함(진료기록부에 설명·동의서 별도 작성·보관). <u>다. 투여중지 기준</u> 1) 동 약제 투여 전 치료법과 비교하여 출혈건수가 증가하는 경우 2) 해당 약제 투여 이후 6개월마다 평가하여 투여 전 치료법 대비 50% 이상의 출혈건수 감소가 유지되지 않은 경우	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	요양기관이 관리한 경우에 한함. <u>라. 투여중지 기준(→ 1호 다.로 변경)</u> 1) 동 약제 투여 전 치료법과 비교하여 출혈건수가 증가하는 경우 2) 해당 약제 투여 이후 6개월마다 평가하여 투여 전 치료법 대비 50% 이상의 출혈건수 감소가 유지되지 않은 경우 <u>마. 1년 이상 혈우병 진료 실적이 있는 혈액종양 소아청소년과/혈액종양 내과 전문의 또는 5년 이상 혈우병 진료 실적이 있는 소아청소년과/내과 전문의의 처방에 한하여 요양급여를 인정함.</u> <u>(→ 4호로 변경)</u> <u><추 가></u>	2. 만 1세 이상의 제8인자 항체를 보유하지 않은 중증(응고인자 활성도가 1%	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>미만) A형 혈우병 환자</u> <u>가. 투여대상</u> 1) <u>중추신경계, 기도 및 폐출혈 등 입원을 동반한 중증출혈 병력이 확인된 환자</u> 2) <u>24주 이상 지속적으로 8인자제제를 투여 중인 환자* 중 최소 20 노출일(Exposure Day: ED) 이상 달성한 환자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우</u> * <u>단, 8인자제제를 20 노출일 이상 달성한 시점에 만 2세 미만의 환자의 경우 8인자제제의 지속적인 투여기간이 24주 미만이라도 의료진이 임상적 유용성이 위험성을 상회한다고 판단하여 투여소견서를 첨부하는 경우 인정</u> <u>- 다 음 -</u> <u>가) 최근 24주간 진료기록에 확인된 출혈건수가 6회 이상(만12세 미</u>	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>만은 최근 24주간 출혈건수가 3회 이상)인 경우</u> <u>나) 혈우병성 관절병증이 현재 단순 엑스선 상 확인되고 진행성인 경우</u> <u>다) 관절초음파 혹은 MRI상 확인되고, 기타 방법으로 치료할 수 없는(소견서 첨부) 소아의 만성 혈액막염</u> <u>나. 투여 시 고려사항</u> <u>의료진은 상기 2. 투여대상의 경우, 임상적 유용성이 허가사항의 사용상의 주의사항에 따른 위험정보다 높다고 판단되는 경우, 8인자제제에 대한 면역관용(tolerance) 획득에 미칠 수 있는 영향 등에 대하여 환자에게 충분히 설명한 이후, 동 약제 투여에 대하여 해당환자(보호자)가 동의한 경우에 투</u>	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>여하도록 함.(진료기록부에 설명·동의서 별도 작성·보관).</u> <u>다. 투여중지 기준</u> <u>해당 약제 투여 이후 6개월마다 평가하여 ABR*(자발출혈 또는 일상생활 관련 출혈)이 5 이상일 경우</u> <u>* ABR(Annualized bleed rate) = 출혈 횟수/(치료일수/365.25)</u> <u>라. 8인자제제와 동시 처방</u> <u>○ Emicizumab 유지요법 중인 환자에서 8인자제제의 처방은 출혈이 있어 내원 시 원내에서의 투여분과 외래에서의 20-25 IU/kg 2회분 처방에 한해 인정함.</u> <u>- 다만, 중등도(moderate) 이상 출혈의 경우 의사의 의학적 판단에 따라서 최대 30 IU/kg</u>	

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>3.</u> 투여방법 부하용량 투여 기간 동안 원내 투여를 원칙으로 하며, 해당기간 동안 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이상 성공적인 자가투여를 병원에서 확인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 4주분까지 요양급여를 인정함. 이후 처방은 투약 등의 확인을 위한 일지를 환자 및 보호자가 작성하고 이를 요양기관이 관리한 경우에 한함. <u>4.</u> 1년 이상 혈우병 진료 실적이 있는 혈액종양 소아청소년과/혈액종양 내과 전문의 또는 5년 이상 혈우병 진료 실적이 있는 소아청소년과/내과 전문의의 처방에 한하여 요양급여를 인정함.	

※ 관련근거

1. Hematology: Basic Principles and Practice, 8e, 2022, Chapter 134. Hemophilia A and B
2. Conn's Current Therapy 2023, Chapter. Hemophilia and Related Conditions
3. Ferri's Clinical Advisor 2023, Chapter. Hemophilia

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
4, Nelson Textbook of Pediatrics, 21e, 2020, Chapter 503. Hereditary Clotting Factor Deficiencies (Bleeding Disorders)			
5. Goldman-cecil Medicine, 26e, 2020, Chapter 165. HEMORRHAGIC DISORDERS: COAGULATION FACTOR DEFICIENCIES			
6, WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020;26(Suppl 6):1 - 158.			
7. 日本血栓止血學會血友病患者に對する止血治療ガイドライン：2019年補遺版ヘムライブラ®（エミシズマブ）使用について. 血栓止血誌 2020;31(1):93-104			
8. National Hemophilia Foundation for all bleeding disorders, Recommendation On The Use And Management Of Emicizumab-kxwh (Hemlibra®) For Hemophilia A With And Without Inhibitors(2022), MASAC Document #268			
9. Guidelines on the use of prophylactic factor replacement for children and adults with Haemophilia A and B. British Society for Haematology, 2020			
10. Practical Guidance of the GTH Haemophilia Board on the Use of Emicizumab in Patients with Haemophilia A. on behalf of the Haemophilia board of the German, Swiss Austrian Society for Thrombosis Haemostasis Research (GTH). Hämostaseologie 2020;40:561 - 571.			
11. Mahlangu et al. Emicizumab Prophylaxis in Patients Who Have Hemophilia A without Inhibitors. N Engl J Med 2018;379:811-22.			
12. Shima et al. A multicentre, open label study of emicizumab given every 2 or 4 weeks in children with severe haemophilia A without inhibitors. Haemophilia. 2019;25:979 - 987.			
13. Pipe et al. Efficacy, safety, and pharmacokinetics of emicizumab prophylaxis given every 4 weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a multicentre, open-label, non-randomised phase 3 study. Lancet Haematol 2019;6(6):e295-e305			
14. Callaghan et al. Long-term outcomes with emicizumab prophylaxis for hemophilia A with/without FVIII inhibitors from the HAVEN 1-4 studies. Blood. 2020 Dec 10;blood.2020009217.			
15. Gouw SC et al. Intensity of factor VIII treatment and inhibitor development in children with severe hemophilia A: the RODIN			

[339] 기타의 혈액 및 체액용약

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
study. Blood. 2013 May 16;121(20):4046-55.			
16. van den Berg HM et al. Timing of inhibitor development in more than 1000 previously untreated patients with severe hemophilia A. Blood. 2019 Jul 18;134(3):317-320.			
17. Hay CR et al. Incidence of factor VIII inhibitors throughout life in severe hemophilia A in the United Kingdom. Blood. 2011 Jun 9;117(23):6367-70.			